MINI-PBL – NECK PAIN (UNIT 3, WEEK 5)

حالة مصغّرة – ألم الرقبة (الوحدة الثالثة، الأسبوع الخامس)

Unit 3 Week 5 – Complementary mini-PBL – College of Medicine

الوحدة الثالثة الأسبوع الخامس – حالة مصغّرة تكميلية – كلية الطب

1. THE CASE AND THE FILM | الحالة والصورة الشعاعية

Case Presentation | عرض الحالة

Nader, a **45-year-old carpenter**, complains of **neck pain for the last 2 months** that **increases with neck movements**. The pain **radiates along the right shoulder and upper limb** and **continues to get worse**. He mentions a **history of neck injury a few years ago**.

نادر، نجار عمره 45 سنة، يشكو من **ألم في الرقبة منذ شهرين يزداد بحركات الرقبة**. ينتشر الألم **على طول الكتف الأيمن والطرف العلوي ويزداد سوءاً باستمرار**. ويذكر **قصة إصابة في الرقبة قبل بضع سنوات**.

- **Examination: limited ability to flex the head to the sides** and **limited ability to rotate the head**.

  الفحص: قدرة محدودة على ثني الرأس إلى الجانبين وقدرة محدودة على تدوير الرأس.

- **Two weeks ago** he developed a **tingling sensation and numbness along the right shoulder and the lateral side of the arm and forearm**.

  منذ أسبوعين ظهر لديه **إحساس بالتنميل وخدر على طول الكتف الأيمن والجانب الوحشي للذراع والساعد**.

- **Figure 1** is the **lateral view X-ray of the cervical spine**, labelled **"spur of bone"** and **"narrowing of disc"**.

  الشكل 1 صورة شعاعية **جانبية للعمود الفقري العنقي**، عليها إشارتا **"نتوء عظمي"** و**"تضيق القرص"**.

2. THE EIGHT QUESTIONS AND STANDARD ANSWERS | الأسئلة الثمانية والإجابات المعتادة

Questions in the Case | أسئلة الحالة

- **Q1** What are the possible causes of neck pain? **Q2** What is the significance of the old neck injury? **Q3** Which spinal nerves are likely to be involved? **Q4** What is the likely diagnosis?

  س1 ما الأسباب المحتملة لألم الرقبة؟ **س2** ما أهمية إصابة الرقبة القديمة؟ **س3** أي الأعصاب الشوكية يُحتمل أن تكون مشاركة؟ **س4** ما التشخيص المرجح؟

- **Q5** Give the number of the vertebra marked with the white arrow and identify the structure marked with a star. **Q6** What motor manifestations may complicate the condition? **Q7** What are the radiological findings? **Q8** What are the main lines of management?

  س5 أعطِ رقم الفقرة المشار إليها بالسهم الأبيض وحدد البنية المشار إليها بنجمة. **س6** ما المظاهر الحركية المحتملة التي قد تعقّد الحالة؟ **س7** ما الموجودات الشعاعية؟ **س8** ما الخطوط الرئيسية للتدبير؟

> The case file **does not give answers**; the table below uses **standard medical teaching**, and **Q5 cannot be answered from the supplied page** (check your copy of the figure).
>
> ملف الحالة **لا يتضمن الإجابات**؛ ويستعمل الجدول التالي **المعرفة الطبية المعتادة**، و**لا يمكن الإجابة عن س5 من الصفحة المرفقة** (راجع نسختك من الصورة).

Answers (Standard Teaching) | الإجابات (من التعليم المعتاد)

Question السؤال	Answer الإجابة
Q1 Causes of neck pain **س1 أسباب ألم الرقبة**	**Cervical spondylosis, disc prolapse, muscle or ligament strain, trauma (whiplash), infection, inflammatory arthritis, tumor, referred pain** **التنكس الفقاري العنقي، وانزلاق القرص، وشد العضلات أو الأربطة، والرضح (إصابة السوط)، والعدوى، والتهاب المفاصل الالتهابي، والأورام، والألم المنتقل**
Q2 Old injury **س2 الإصابة القديمة**	Trauma **accelerates degenerative changes** of discs and facet joints يسرّع الرضح **التغيرات التنكسية** في الأقراص والمفاصل الوجيهية
Q3 Nerves **س3 الأعصاب**	**C5 and C6 roots**: shoulder and lateral arm (C5), lateral forearm (C6) **جذرا C5 وC6**: الكتف والجانب الوحشي للذراع (C5) والجانب الوحشي للساعد (C6)
Q4 Diagnosis **س4 التشخيص**	**Cervical spondylosis with radiculopathy** **التنكس الفقاري العنقي مع اعتلال جذري**

Question السؤال	Answer الإجابة
Q6 Motor manifestations **س6 المظاهر الحركية**	Weak **shoulder abduction (deltoid, C5)**, **elbow flexion (biceps)** and **wrist extension (C6)**; **reduced biceps reflex**; later **muscle wasting** ضعف **تبعيد الكتف (الدالية، C5)** وثني المرفق (ذات الرأسين) وبسط الرسغ (C6)؛ ونقص منعكس ذات الرأسين؛ وفي مرحلة لاحقة ضمور العضلات
Q7 Radiology **س7 الشعاعية**	**Osteophytes (spurs), narrowing of the disc space, reduced cervical lordosis, narrowed intervertebral foramina** **نتوءات عظمية، وتضيق الحيز القرصي، ونقص التقعر العنقي، وتضيق الثقوب بين الفقرية**
Q8 Management **س8 التدبير**	**Analgesics/NSAIDs, physiotherapy and exercises, posture and workplace modification, a short period of soft collar, injections if needed; surgery for progressive weakness or myelopathy** **المسكنات/مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والعلاج الفيزيائي والتمارين، وتعديل الوضعية وبيئة العمل، وطوق عنق لين لفترة قصيرة، وحقن عند الحاجة؛ والجراحة للضعف المتفاقم أو اعتلال النخاع**